

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0200

Paginas del documento: 10

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

alence of breastfeeding in the first hour of life; however, no associations were identified with route of childbirth and other

Objetivo: Analizar índices de lactancia materna en la primera hora de vida de primíparas y su relación con la vía de parto.

Métodos: Estudio transversal anidado en un ensayo clínico. Se incluyeron primíparas, mayores de 18 años, con nacimiento de neonato único, vivo, a término, con peso superior a 2.500 gramos, hemodinámicamente estables, conscientes y orientadas, atendidas en maternidades vinculadas a hospitales universitarios, ubicadas en el interior del estado de Minas Gerais y en el municipio de Rio de Janeiro, entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Se utilizó un instrumento elaborado para el estudio, validado por especialistas. Se aplicaron las pruebas ji cuadrado y exacta de Fisher, con un nivel de significación del 5 %. Se calcularon razones de prevalencia e intervalos de confianza de 95 %. Se realizó análisis múltiple aplicado mediante la regresión de Poisson, con varianza robusta, y se incluyeron en el modelo variables con valor de $p < 0,20$ en el bivariado. La lactancia materna en la primera hora de vida fue la variable dependiente y la vía de parto y otras variables de interés fueron las independientes.

Resultados: Se incluyeron 102 primíparas y el índice de lactancia materna en la primera hora de vida fue del 21,6 %. El análisis bivariado indicó relación entre la práctica y la Iniciativa Hospitales Amigos del Niño ($p = 0,05$), el asesoramiento sobre lactancia en la atención prenatal ($p = 0,027$) y el contacto piel con piel ($p < 0,001$). Ninguna variable explicó la práctica a partir del modelo de regresión.

Conclusión: Hubo baja prevalencia de lactancia materna en la primera hora de vida, pero no se identificó relación con la vía de parto y otras variables.

Registro REBEC: RBR-4w9v5rq

Introdução

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi criada em 1991, como estratégia de promoção e prevenção ao aleitamento materno pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Propõe no âmbito hospitalar a adoção de dez passos para o sucesso do aleitamento materno. Destaca-se o quarto passo, em que se recomenda colocar os neonatos em contato com suas mães imediatamente após o parto, durante, pelo menos, uma hora ininterruptamente.^(1,2)

A prática é altamente recomendada uma vez que imediatamente após o parto, o neonato encontra-se em período de maior alerta e com isso, mais apto a iniciar a amamentação, pois tem capacidade de se mover para a região mamilo-areolar e sugar prontamente, o que não se mantém após a primeira hora, em que geralmente encontram-se em estado de sono.^(3,4)

De acordo com a OMS, 80% dos RN recebem o leite materno em algum momento da vida e 48% iniciam o aleitamento na primeira hora de vida.^(5,6) Um a cada dois neonatos são amamentados na primeira hora de vida no mundo, no entanto, os indicadores se comportam de forma diferente em cada

Os dados apontam que na América Latina, 53,9% dos neonatos iniciam o aleitamento na primeira hora,⁽⁷⁾ e no Brasil, a taxa de aleitamento materno na primeira hora de vida é de 62,4%.⁽⁸⁾

Observa-se, no entanto, grande variação quanto a estes indicadores no território nacional. Estudo Nacer no Brasil, realizado nos anos de 2011 e 2012, identificou taxa de 60,9% de amamentação na primeira hora de vida.⁽⁹⁾ No entanto, estudos regionais apresentaram menores taxas variando de 28,7% no Recife⁽¹⁰⁾ a 49,5%, no interior da Bahia.⁽¹¹⁾

Ressalta-se que o aleitamento materno na primeira hora de vida aumenta a chance de sobrevivência da criança, além dos benefícios para sua saúde ao longo do tempo. Iniciar o aleitamento entre duas e 23 horas após o nascimento aumenta seu risco de mortalidade em 1,3 vezes e, quando iniciado após 24 horas, o risco de morte dobra em relação aos neonatos que foram amamentados na primeira hora.⁽¹²⁾

Estudo de revisão apontou que o sucesso da implementação do aleitamento na primeira hora de vida é complexo e multifatorial. A cesárea apresentou-se como uma grande barreira para a prática. Outro fator elencado refere-se ao contato pele a

aleitamento. A revisão evidencia a cultura organizacional e a iros atuantes em sala de parto como fatores protetores para a prática.⁽¹³⁾

Observa-se ainda ampla diversidade de fatores associados à amamentação na primeira hora de vida. Dentre os sociodemográficos destacam-se: escolaridade materna superior a 12 anos,⁽¹¹⁾ como fator de proteção e a menor idade materna, como possível fator de risco.⁽¹⁴⁾ Em relação aos fatores associados à gestação: a gestação planejada;⁽¹⁵⁾ realizar o pré-natal em serviço público;⁽¹⁵⁾ ter orientações no pré-natal sobre pega e posicionamento da criança e sobre a importância do aleitamento,^(11,15) favoreceram o aleitamento na primeira hora de vida.

No tocante à assistência ao parto, estudos destacam que ter o parto em serviço público;⁽¹⁵⁾ ser o parto realizado em Hospital Amigo da Criança;⁽¹¹⁾ ter enfermeiros atuantes em sala de parto,⁽¹⁰⁾ foram associados a maiores índices de aleitamento na primeira hora. Além disso, o estudo Nascer no Brasil evidenciou que ter o parto assistido por enfermeiros obstetras aumenta em 64% as chances de amamentar na primeira hora de vida.⁽⁹⁾

Variáveis relacionadas ao neonato também são descritas como fatores associados à amamentação em sala de parto. Escores de Apgar superiores a oito no primeiro minuto de vida⁽¹⁴⁾ e peso de nascimento igual ou superior a três quilos,^(10,14) foram associados à maiores chances de aleitamento precoce, indicando a influência das condições clínicas do neonato para a prática.

O contato pele a pele imediatamente após o parto se comporta como um preditor e fator de proteção à amamentação precoce,^(10,13-15) devendo ser esta prática estimulada para aumentar os índices de aleitamento materno na primeira hora de vida.

Já a influência da cesárea na prática do aleitamento na primeira hora de vida ainda não está completamente elucidada na literatura, apresentando-se como uma lacuna do conhecimento. Estudos demonstram associação positiva entre o parto vaginal e o aleita-

(9,15)

hora de vida foi inferior nas mulheres submetidas à cesárea, no entanto, não foram encontradas associações estatisticamente significantes.⁽¹⁰⁾

Ademais, observa-se altos índices de cesáreas em primíparas, o que pode comprometer sua vida reprodutiva e aumentar a probabilidade de cesáreas recorrentes.⁽¹⁶⁾ Ressalta-se ainda que as experiências prévias relacionadas tanto ao parto quanto à amamentação influenciam a mulher em uma nova experiência de amamentação.⁽¹⁷⁾ Contudo, não encontra-se na literatura estudos que avaliem a associação entre o aleitamento materno na primeira hora de vida entre primíparas submetidas à cesárea.

Dadas as divergências e as lacunas de conhecimento, identifica-se a necessidade de maior investigação da influência da via de parto nos indicadores de aleitamento materno na primeira hora de vida e, mais especificamente, entre primíparas, justificando o desenvolvimento deste estudo.

De forma que esta pesquisa teve como objetivo analisar índices de aleitamento materno na primeira hora de vida entre primíparas e associação com a via de parto.

Métodos

Trata-se de estudo transversal aninhado a ensaio clínico cujas recomendações da *STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology* (STROBE) foram adotadas.⁽¹⁸⁾

O estudo foi realizado nas unidades de Alojamento Conjunto (AC) de uma maternidade do interior de Minas Gerais (centro A) e outra, localizada no município do Rio de Janeiro (centro B), ambas instituições de ensino vinculadas às respectivas universidades.

O centro A é um hospital público com 100% dos atendimentos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS); referência para resolução de gestações de alto risco e moléstias infecciosas no ciclo gravídico-puerperal. O AC possui 12 leitos e protocolo

tura para acomodar a puér-
e o acompanhante durante

O centro B também caracteriza-se como hospital público vinculado ao SUS e oferece assistência ambulatorial, hospitalar e multiprofissional na atenção à saúde de gestantes e recém-nascidos de alto risco. Possui ambulatorios especializados na assistência pré-natal (hipertensão arterial, diabetes, gestação gemelar, patologias fetais e adolescentes), programa de rastreio de risco para gestantes no primeiro trimestre, planejamento familiar para mulheres de risco, genética pré-natal e medicina fetal. O AC possui nove enfermarias compostas por cinco leitos, totalizando 45 leitos. A instituição recebeu o título de Hospital Amigo da Criança em dezembro de 2020. Destaca-se que como as enfermarias são coletivas neste centro, selecionou-se apenas uma diáde para o estudo de cada enfermaria, para evitar possíveis vieses de resposta.

O estudo faz parte de um estudo maior (ensaio clínico randomizado). Para este, realizou-se o estudo-piloto com recrutamento de 40 participantes, 20 alocadas para o grupo intervenção (GI) e 20, grupo controle (GC), com distribuição igual nos dois centros. O cálculo amostral foi realizado pelo Programa Open Epi® e confirmado pelo programa PASS®, a partir dos resultados obtidos, considerando nível de significância de 5% e poder estatístico 80%, previu-se a inclusão de 88 mulheres, estimando-se possível perda de 20% da amostra, o cálculo amostral final recomendou a inclusão de 102 mulheres, com igual distribuição entre os grupos, sendo 51 pertencentes ao GI e 51 ao GC.

O ensaio clínico (Registro REBEC RBR-4w9v5rq) teve por objetivo testar a efetividade do aconselhamento em aleitamento materno durante a internação da diáde no AC nos índices de aleitamento materno exclusivo. No GI as mulheres foram abordadas utilizando o aconselhamento e foram realizadas de duas a quatro sessões, sendo questionados após a alocação, como a mesma estava se sentindo amamentando, assim como suas dúvidas,

feto único, com nascimento vivo, idade gestacional de 37 a 42 semanas, peso de nascimento superior a 2.500 gramas, independentemente do tipo de parto; hemodinamicamente estáveis, conscientes, orientadas e internadas no AC dos centros participantes, no momento da alocação para o estudo.

Foram excluídas puérperas e neonatos com contraindicação para o aleitamento (HIV positivo; HTLV 1 e 2 positivo e/ou tratamento neoplásico com quimioterápicos); neonatos com malformações que impedissem ou dificultassem o aleitamento; puérperas cujos neonatos foram imediatamente separados após o clampeamento do cordão umbilical ao nascimento devido a intercorrências materno-neonatais, em que um ou ambos foram internados em Unidades Críticas; puérperas transferidas de outras instituições ou que já tinham recebido alta (reinternação), puérperas usuárias de drogas ilícitas, puérperas diagnosticadas com déficit intelectual e/ou sensorial, com estas informações destacadas com diagnóstico médico em prontuário das mesmas.

Após serem esclarecidas e consentirem em participar do estudo, as mulheres foram convidadas a responder um formulário construído e validado pelos pesquisadores, contendo dados sociodemográficos, clínicos e obstétricos.

Composto por três sessões, onde a primeira refere-se às variáveis sociodemográficas (idade – em anos; cor autodeclarada; se vivia com companheiro; escolaridade; renda familiar e, se exercia ocupação remunerada). Na segunda sessão foram abordadas as seguintes variáveis clínicas: tabagismo, problemas de saúde (doenças crônicas ou adquiridas durante o ciclo gravídico-puerperal) e uso de medicamentos diário.

A terceira sessão abrangeu os dados obstétricos a saber: realização de pré-natal e número de consultas, orientações relacionadas à amamentação durante o pré-natal com referência da fonte e profissional que as realizou. As variáveis referentes ao parto foram: via de parto; presença de acompanhante no parto; contato pele a pele após o nascimento; amamentação na primeira hora de vida. Foram coletados ain-

rto e variáveis sociodemográficas consistiram nas variáveis

Os dados coletados por meio do Google Forms® foram importados para planilha do aplicativo Microsoft Excel® e, após, para o aplicativo *Statistical Package for the Social Sciences*, versão 23.0. Realizou-se a análise descritiva dos dados relativos às variáveis sociodemográficas, clínicas, obstétricas e neonatais (números absolutos e percentuais, média, desvio padrão, valores mínimos e máximos). Foram aplicados os Testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher, considerando nível de significância de 5%; cálculos das razões de prevalência e respectivos intervalos de confiança foram de 95%. A análise múltipla foi aplicada por meio da regressão de Poisson, com variância robusta, incluindo no modelo variáveis com valor de $p < 0,20$ na bivariada.

O presente estudo consistiu em um dos objetivos de um projeto maior, intitulado “Efetividade do aconselhamento individualizado na duração do aleitamento materno exclusivo: ensaio clínico, multicêntrico, randômico, paralelo e aberto”. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do centro A, parecer nº 6274311 (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética: 61321122.3.1001.8667) de 06 de setembro de 2022 e Comitê do centro B, sob parecer nº 6494723 (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética: 61321122.3.3001.5275) de 21 de setembro de 2022. Desta forma, o estudo foi guiado pelas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos, contidas na Resolução 466/2012/CNS/MS, sendo assegurado que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado por todas as participantes do estudo.

Resultados

Foram incluídas 102 puérperas. Destas, 54 (52,9%) estavam assistidas em uma maternidade que possui título de Hospital Amigo da Criança (IHAC)

43 anos, com média de 25,77 anos (DP: 6,36), 12 (11,8%) com idade superior a 35 anos. A maioria das mulheres se autodeclarou parda - 61 (59,8%), vivia com companheiro - 77 (75,5%) e tinha escolaridade superior ao ensino médio completo - 89 (87,3%). A renda familiar relatada por 70 mulheres (68,6%) foi de dois a três salários mínimos e 32 (31,4%) relataram renda igual a um salário mínimo. A maioria das mulheres exercia ocupação remunerada - 60 (58,8%), com vínculo empregatício formal - 52 (86,6%).

Quanto às variáveis clínicas, seis (5,9%) eram tabagistas; 47 (46,1%) tinham problemas de saúde prévios ou que ocorreram na gestação e 33 (32,4%) faziam uso diário de medicamento. Foram descritos com maior frequência ocorrência de diabetes (22), hipertensão (15) e hipotireoidismo (oito), todos relacionados à gestação e ressalta-se que a mulher poderia apresentar mais de um problema de saúde concomitante. As medicações mais citadas foram a metildopa (13), a insulina (oito) e a levotiroxina (sete). Destaca-se que nenhuma das patologias ou medicamentos contraindicavam o aleitamento materno.

Em relação às variáveis gestacionais, todas as mulheres realizaram o pré-natal e o número de consultas variou de quatro a 30, com média de 9,10 consultas (DP: 3,23) e 97 (95,1%) realizaram número igual ou superior a seis consultas, conforme preconiza o Ministério da Saúde.

A maioria das mulheres recebeu orientação sobre amamentação durante o pré-natal - 62 (60,8%), sendo citados mais comumente como fontes de informação, a consulta pré-natal (45); materiais educativos (21) e a consulta na internet (21). Quando questionadas em caso de orientação profissional, o enfermeiro foi o mais citado (41), seguido pelo médico (31) e nutricionista (oito). Para as fontes e profissionais poderia ser elencada mais de uma resposta.

Houve predomínio de cesáreas na amostra - 56 (54,9%) e o parto normal foi a via de nascimento de 46 neonatos (45,1%). A maioria relatou presença de

to e o aleitamento materno
a foi realizado apenas por 22

O peso dos neonatos variou de 2550 a 4155 gramas, com média de 3208,61 gramas (DP: 415,64) e a estatura, de 41,5 a 53 cm, com média de 47,73 cm (DP: 2,28). A idade gestacional variou de 37 a 41 semanas, com média de 38,89 semanas (DP: 1,27). Desta forma, nota-se que todos os neonatos nasceram a termo e com peso adequado para idade ao nascimento, sendo consideradas condições favoráveis para o aleitamento materno.

Na tabela 1, apresenta-se a análise bivariada da associação entre variáveis sociodemográficas, clínicas, obstétricas e neonatais e a prática do aleitamento materno na primeira hora de vida.

As variáveis ser uma maternidade IHAC ($p = 0,05$); ter recebido informações sobre aleitamento materno no pré-natal ($p = 0,027$) e ter realizado contato pele a pele com o RN ($p < 0,001$) foram associadas à amamentação na primeira hora. Ao analisar a razão de prevalência observa-se que a prática do aleitamento materno na primeira hora de vida em maternidade não credenciada à IHAC foi 2,37 vezes menor do que entre a maternidade credenciada. Ter recebido orientação sobre amamentação no pré-natal aumentou a prevalência da prática em 2,90 vezes e ter realizado contato pele a pele com RN mostrou-se como fator de proteção para o aleitamento na primeira hora de vida com prevalência 0,67 vezes maior de ocorrer neste momento, conforme apresentado na tabela 1.

Na tabela 2, são apresentadas as variáveis inseridas no modelo de regressão de Poisson com variância robusta. Através do modelo, nenhuma variável explicou a prática do aleitamento materno na primeira hora de vida na amostra de estudo, conforme exposto na tabela 2.

cas, clínicas e obstétricas.

A prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida na amostra de estudo, de acordo com a classificação da OMS para o indicador, classificou-se como “muito ruim”.⁽¹⁹⁾ A OMS classifica os percentuais de adesão ao aleitamento na primeira hora para mães e recém-nascidos em condições favoráveis ao aleitamento, entre zero a 29% como “muito ruim”, 30 a 49% “ruim”, 50 a 89% “bom” e de 90 a 100% “muito bom”.⁽¹⁹⁾ Ainda, a prevalência foi inferior a dados nacionais^(8,11,20) e internacionais,^(5,6) indicando a necessidade de melhorias nesta prática.

Acredita-se que o fato do indicador ser “muito ruim” se deve às culturas organizacionais e, neste sentido, mais investimentos devem ser feitos para conscientizar as equipes sobre os benefícios da prática. No entanto, não é possível afirmar o motivo para a baixa prevalência. Porém, os resultados desse estudo foram divulgados às instituições que vêm buscando estratégias para sua implementação.

O cenário apresentado no presente estudo, assemelha-se aos dados do estudo Nascer no Brasil, realizado em 2011, que apontou prevalência de 17% de aleitamento materno na primeira hora de vida. Contudo, estudo de avaliação da Rede Cegonha realizado em 2017, mostra avanços na prática, alcançando prevalência de 31% no território nacional.⁽²¹⁾ Destaca-se que desde setembro de 2024, a Rede Cegonha, posteriormente Rede Materno Infantil (RAMI) foi substituída pela Rede Alyne, que prioriza ações de incentivo, promoção e proteção ao Aleitamento Materno.

Estudo de avaliação da Rede Cegonha identificou ainda que a prevalência de contato pele a pele foi de 67,5%, no entanto, menos da metade das díades iniciaram a amamentação em sala de parto.⁽²¹⁾ Neste sentido, reflete-se sobre as boas práticas realizadas nas instituições estudadas, já que 64,7% das díades realizaram o contato pele a pele precocemente, no entanto, cerca de um terço destes, iniciou a amamentação, que poderia ser favorecida pelo contato.

Discussão

	Sim n(%)	Não n(%)	RP	IC 95%	p-value
Não	16(15,7)	38(37,2)	2,37	(1,01 - 5,57)	0,053*
Idade					
18 a 35 anos	20(19,6)	70(68,6)	0,75	(0,20 - 2,82)	1,000
> 35 anos	02(2,0)	10(9,8)			
Cor da pele					
Branca	05(4,9)	14(13,7)	0,78	(0,33 - 1,85)	0,550
Não branca	17(16,7)	66(64,7)			
Companheiro					
Vive com companheiro	15(14,7)	62(60,8)	0,70	(0,32 - 1,51)	0,406
Não vive com companheiro	07(6,9)	18(17,6)			
Escolaridade					
Ensino médio incompleto ou inferior	01(1,0)	12(11,8)	3,61	(0,45 - 20,92)	0,289
Superior ao ensino médio completo	21(20,6)	68(66,6)			
Renda familiar					
1 salário mínimo	08(7,8)	24(23,5)	0,80	(0,37 - 1,71)	0,609
Acima de 2 salários mínimos	14(13,7)	56 (55,0)			
Ocupação remunerada					
Exerce ocupação remunerada	12(11,8)	48(47,0)	0,84	(0,40 - 1,76)	0,807
Não exerce ocupação remunerada	10(9,8)	32(31,4)			
Tabagismo					
Sim	02(2,0)	04(3,9)	1,60	(0,48 - 5,30)	0,607
Não	20(19,6)	76(74,5)			
Problemas de saúde					
Sim	07(6,8)	40(39,2)	0,55	(0,24 - 1,23)	0,153
Não	15(14,8)	40(39,2)			
Número de consultas pré-natal					
≥ 6	22(21,6)	75(73,5)	0,77	(0,69 - 0,86)	0,582
< 6	-	05(4,9)			
Recebeu orientações sobre AM no pré-natal					
Sim	18(17,6)	44(43,1)	2,90	(1,06 - 7,95)	0,027*
Não	04(3,9)	36(35,4)			
Via de parto					
Parto normal	09(8,8)	37(36,2)	1,05	(0,85 - 1,28)	0,810
Cesárea	13(12,7)	43(42,3)			
Presença de acompanhante					
Sim	21(20,6)	77(75,5)	0,86	(0,15 - 4,88)	1,000
Não	01(1,0)	03(2,9)			
Contato pele a pele com RN					
Sim	22(21,6)	44(43,1)	0,67	(0,56 - 0,79)	<0,001*
Não	-	36(35,3)			

*p <0,05; RP = Razão de Prevalência; IC = Intervalo de Confiança; p = p-value

pondo as evidências. Revisão da literatura verificou que a cesárea atrasa o início do aleitamento materno e consequentemente, compromete a duração do aleitamento na forma exclusiva.⁽²²⁾

Estudo com 648 primíparas chinesas com características semelhantes à amostra de estudo observou que a cesárea apresentou efeitos prejudiciais nos comportamentos precoces de amamentação e que neona-

Tabela 2. Modelo de regressão de Poisson com variância robusta entre aleitamento materno na primeira hora de vida e variáveis significativas

Variáveis	RP	IC95%	p-value
Maternidade IHAC	0,17	(-0,38 - 0,27)	0,744
Problemas de saúde materno	0,15	(-0,21 - 0,39)	0,574
Orientações sobre AM no pré-natal	0,17	(-0,40 - 0,28)	0,728
Contato pele a pele com RN	0,17	(-0,54 - 0,12)	0,211
Via de parto	0,17	(-0,21 - 0,44)	0,500

cidade de apoio à esta mulher na Colômbia apontou que cesárea têm 2,08 vezes mais chances de terem a amamentação postergada⁽²⁵⁾ e, estudo realizado em Portugal mostrou que neonatos nascidos de cesárea tinham duas vezes mais chances de introdução de aleitamento artificial antes do início do aleitamento materno.⁽²⁶⁾ Ainda, estudo com 777 mulheres na Turquia ressaltou que mulheres submetidas à cesárea tem maior risco de início tardio e de amamentação não exclusiva nos três primeiros dias após o parto, em decorrência do adiamento e das dificuldades iniciais.⁽²⁷⁾

Estudo destacou que mesmo eletiva e programada, díades submetidas à cesárea têm maiores chances de não iniciar o aleitamento na primeira hora de vida, independentemente do risco cirúrgico ou condições maternas e neonatais.⁽²⁸⁾

Ressalta-se que cerca de metade das mulheres têm dificuldade com o aleitamento materno nos três primeiros dias, necessitando de suporte.⁽²⁹⁾ Ainda, estudo enfatizou que as primíparas têm mais dificuldade em iniciar o aleitamento materno do que as múltiparas, atrasando seu início.⁽³⁰⁾

Mulheres submetidas à cesárea em maternidade turca apresentavam 6,5 vezes mais chances de obterem menores escores de avaliação da escala LATCH, indicando que possuíam mais dificuldades no processo de aleitamento e necessidade de apoio.⁽³¹⁾ A escala LATCH tem por objetivo sinalizar a necessidade de intervenção imediata, encaminhamentos e apoio após a alta hospitalar. São avaliados por meio dela os itens: pega; deglutição do neonato; tipo de mamilo; conforto e posicionamento e a pontuação de cada item varia de zero a dois. Na somatória dos itens, escores iguais ou abaixo de seis indicam dificuldades no processo de aleitamento humano e necessidade de suporte.⁽³²⁾ Portanto, as evidências sugerem fortemente a necessidade de apoio e suporte ao aleitamento materno, principalmente entre mulheres submetidas à cesárea e primíparas, que foram alvo deste estudo.

tudo, realizado com 93 mulheres na Espanha mostrou melhorias significativas no processo inicial de aleitamento. Também observou-se que o uso da escala LATCH para avaliação de dificuldades na amamentação; o apoio profissional e o registro da passagem de plantão teve impacto positivo nos índices. Ainda, detectou-se que muitos profissionais desconheciam a possibilidade do contato precoce e dos benefícios do aleitamento na primeira hora, sendo a capacitação, essencial para mudanças na filosofia institucional.⁽³³⁾

Neste sentido, estudo qualitativo realizado com 19 mulheres chinesas submetidas à cesárea desvelou que as motivações para o aleitamento materno se dão devido ao conhecimento dos benefícios do AM, o apoio profissional recebido e a responsabilidade exclusiva pela amamentação. Como desafios para amamentar, foram citados, os desconfortos físicos proporcionados pela cesárea; o déficit de conhecimento sobre a amamentação; a baixa ou ausente produção láctea após o parto e o enfrentamento às alterações de humor durante o processo de adaptação à parentalidade.⁽³⁴⁾

Como limitações, podemos citar apenas a inclusão de primíparas na amostra o que compromete a generalização dos resultados, contudo o objetivo dos pesquisadores era avaliar uma amostra homogênea. Além disso, o pequeno número de díades que tiveram o aleitamento na primeira hora de vida, que pode ter comprometido os resultados das associações, inclusive relacionadas ao tipo de parto. Porém, tais limitações indicam lacunas do conhecimento que podem ser sanadas em estudos posteriores.

O aleitamento materno na primeira hora entre primíparas e mais especificamente a influência da via de parto nesta população-alvo apresenta-se como uma lacuna na literatura, o que compromete a comparabilidade dos dados, contudo reforça o ineditismo do estudo.

Como implicações para a prática, sugere-se que os resultados instiguem a reflexão das práticas assistenciais e a adoção das práticas que possam contri-

ento materno na primeira hora e não houve associação com como nenhuma das variáveis do estudo explicou a prática através da análise de regressão múltipla.

Agradecimentos

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Processo nº 402851/2021-8 e Bolsa de Iniciação Científica CNPq para a autora Melissa de Paula Cornélio.

Colaborações

Ruiz MT, Cornélio MP, Resende CV, Silva JA, Ferreira MG, Cavalcanti MC, Christoffel MM e Rodrigues EC declaram que contribuíram com a concepção do estudo, análise e interpretação dos dados, redação do artigo, revisão crítica relevante do conteúdo intelectual e aprovação final da versão a ser publicada.

Referências

3. Righard L, Alade MO. Effect of delivery room routines on success of first breast-feed. *Lancet*. 1990; 336(8723):1105-7.
4. Widstrom AM, Lilja G, Aaltomaa-Michalias P, Dahilof A, Lintula M, Nissen E. Newborn behaviour to locate the breast when skin-to-skin: a possible method for enabling early self-regulation. *Acta Paediatrica*. 2011; 100(1):79-85.
5. Cornélio MP, Ruiz MT, Resende CV, Silva JA, Ferreira MG, Cavalcanti MC, Christoffel MM, Rodrigues EC. A prática da amamentação no primeiro dia de vida: uma revisão integrativa. *Rev Bras Enferm*. 2023; 76(1):e20220012.
6. Cornélio MP, Ruiz MT, Resende CV, Silva JA, Ferreira MG, Cavalcanti MC, Christoffel MM, Rodrigues EC. A prática da amamentação no primeiro dia de vida: uma revisão integrativa. *Rev Bras Enferm*. 2023; 76(1):e20220012.
7. Unveiling the predatory tactics of the formula milk industry [editorial]. *The Lancet*. 2023; 401(10375):409.
8. Cornélio MP, Ruiz MT, Resende CV, Silva JA, Ferreira MG, Cavalcanti MC, Christoffel MM, Rodrigues EC. A prática da amamentação no primeiro dia de vida: uma revisão integrativa. *Rev Bras Enferm*. 2023; 76(1):e20220012.
9. Silva LA, Fonseca VM, Oliveira MI, Silva KS, Ramos EG, Gama SG. Professional who attended childbirth and breastfeeding in the first hour of life. *Rev Bras Enferm*. 2020; 73(2):e20180448.
10. Da Silva JL, Linhares FM, Barros AA, de Souza AG, Alves DS, Andrade PO. Factors associated with breastfeeding in the first hour of life in a Baby-friendly hospital. *Texto Contexto Enferm*. 27(4):e4190017.
11. Sousa PK, Novaes TG, Magalhães EI, Gomes AT, Bezerra VM, Pereira Netto M, et al. Prevalence and factors associated with maternal breastfeeding in the first hour of life in full-term live births in southwest Bahia, Brazil, 2017. *Epidemiol Serv Saude*. 2020; 29(2):e2018384.
12. Cornélio MP, Ruiz MT, Resende CV, Silva JA, Ferreira MG, Cavalcanti MC, Christoffel MM, Rodrigues EC. A prática da amamentação no primeiro dia de vida: uma revisão integrativa. *Rev Bras Enferm*. 2023; 76(1):e20220012.
13. Terra NO, Góes FG, Souza NA, Ledo BC, Campos BL, Barcellos TM. Intervening factors in adherence to breastfeeding within the first hour of life: integrative review. *Rev Eletr Enferm*. 2020; 22: 62254.
14. Saco MC, Coca KP, Abrão AC, Marcacine KO, Abuchaim ES. Skin-to-skin contact followed by breastfeeding in the first hour of life: associated factors and influences on exclusive breastfeeding. *Texto Contexto Enferm*. 2019; 28:e201802.
15. Jesus AS, Santos MY, Santos JM, Freitas CK, Mendes RB, Leite AM, et al. Breastfeeding within one hour of birth among women in the Northeast region of Brazil: prevalence and related factor. *Rev Eletr Enferm*. 2020; 22:58772.
16. Moresi EH, Moreira PP, Ferrer IL, Baptistella MK, Bolognani CV. Robson Classification for cesarean section in a public hospital in Distrito Federal. *Rev Bras Saúde Matern Infant*. 2022; 22(4):1035-42.
17. Huang Y, Ouyang YQ, Redding SR. Previous breastfeeding experience and its influence on breastfeeding outcomes in subsequent births: A systematic review. *Women Birth*. 2019; 32 (4): 303-9.
18. Cusihieri S. The STROBE guidelines. *Saudi J Anaesth*. 2019; 13(Suppl 1):S31-S34.
19. Cornélio MP, Ruiz MT, Resende CV, Silva JA, Ferreira MG, Cavalcanti MC, Christoffel MM, Rodrigues EC. A prática da amamentação no primeiro dia de vida: uma revisão integrativa. *Rev Bras Enferm*. 2023; 76(1):e20220012.
20. Cunha JF, Gama SGND, Thomaz EBAF, Gomes MASM, Ayres BVDS, Silva CMFPD, et al. Factors associated with breastfeeding at birth in maternity hospitals linked to the Rede Cegonha, Brazil, 2016-2017. *Cien Saude Colet*. 2024; 29(4):e04332023.
21. Gomes MASM, Esteves-Pereira AP, Bittencourt SDA, Augusto LCR, Lamy-Filho F, Lamy ZC, et al. Care for healthy newborns in Brazil: are

er cesarean section. *Breastfeed Med.*

DYT, Lok KYW, Tarrant M. Association between intrapartum factors and the time to breastfeeding initiation. *Breastfeed Med.* 2020; 15(6):394-400.

25. Finnie S, Pérez-Escamilla R, Buccini G. Determinants of early breastfeeding initiation and exclusive breastfeeding in Colombia. *Public Health Nutr.* 2020; 23(3):496-505.
26. Branco J, Manuel AR, Completo S, Marques J, Rodrigues Antão R, Pinto Gago C, et al. Prevalence and predictive factors of exclusive breastfeeding in the first six months of life. *Acta Med Port.* 2023;36(6):416-23.
27. Paksoy Erbaydar N, Erbaydar T. Relationship between caesarean section and breastfeeding: evidence from the 2013 Turkey demographic and health survey. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2020; 20(1):55.
28. Mallick LM, Shenassa ED. Variation in breastfeeding initiation and duration by mode of childbirth: A prospective, population-based study. *Breastfeed Med.* 2024;19(4):262-74.
30. Neves RO, Bernardi JR, Silva CHD, Goldani MZ, Bosa VL. Can parity influence infant feeding in the first six months of life? *Cien Saude Colet.* 2020; 25(11):4593-4600.
31. Fadiloglu E, Karatas E, Tez R, Cagan M, Unal C, Nar M, et al. Assessment of factors affecting breastfeeding performance and LATCH Score: A prospective cohort study. *Z Geburtshilfe Neonatol.* 2021;225(4):353-60.
32. Griffin CM, Amorim MH, Almeida FA, Marcacine KO, Goldman RE, Coca KP. LATCH as a systematic tool for assessment of the breastfeeding technique in maternity. *Acta Paul Enferm.* 2022; 35: eAPE03181.
33. Saus-Ortega C. Promoting correct positioning and attachment in breastfeeding infants born by section cesarean in the La Fe Hospital in Spain: a best-practice implementation project. *JBIM Evid Implement.* 2020; 18(3):297-307.
34. Wen J, Yu G, Kong Y, Liu F, Wei H. An exploration of the breastfeeding behaviors of women after cesarean section: A qualitative study. *Int J Nurs Sci.* 2020; 7(4):419-26.